

NS 227310117

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO

IDADE: 64 PESO: 47 ALTURA: 158 PROFISSÃO: do lar
 SINTOMAS: sonolência diurna / acordava assustada e engasgo
 QUEIXAS: edema de membros
 MEDICAMENTOS: glifage / NPH - regular / sirtostatina / tonalapril
 DM - HAS / Tapazol / metformina

MÉDICO: Drº Luis Sérgio

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: N

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 5:30 - 6:00

COCHILHO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO Dorme de lado (E).

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globoso CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 25.7 e/ev SPO2: 94%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (S)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA

(S)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS

Der mmII → edemaciado.

13/11/23 - avaliação

20/11 P = 7.0cm mediana / 90% = 9.5cmH₂O

23 IAH = 0.9 e/ev

M de uso: 5h.

Bem adaptado, relata melhora (fua)
da circulação segue.06/12/23 P = 5.6cmH₂O P90: 8.16cmH₂O

IAH = 1.0 e/ev.

m de uso = 6h

fuga 7.5 l/min

- Deixo P fixa 6.0cmH₂O22/01 P = 6cmH₂O

24 IAH = 0.4

m. de uso = 6h11'

Relata melhora do engasgo, sonolência diurna.

fua.

25/03 P = 6cmH₂O

24 IAH = 0.8 e/ev

m. de uso: 6:00 h.

Bem adaptado.
melhora do quadro

fua

20/06 P = 6cmH₂O

24 IAH = 1.2 e/ev

m. de uso: 6h

Fuga = 8.4 lpm (max) - 5.3 lpm (média)

22/08
24

P = 6cmH₂O
m. de uso = 7hr
IAH = 1,1 e/ev

Relata dor na face, por conta da sinusite,
edema na face.
Máscara ruim. sua

09/12
24

P = 6cmH₂O
IAH = 1 e/ev
m. de uso: 6hr.
Bem adaptada.

Melhora da sinusite;
melhora da insulina;
relata ter ↓ peso 3kg; sua

05/02
25

P = 6cmH₂O
IAH = 1,5 e/ev
m. de uso: 5h44'
Bem adaptada,

Melhora da sinusite
↓ a insulina
P = 84 Kg. sua

03/07
25

P = 6cmH₂O
IAH = 2,3 e/ev
m. de uso = 2,5 lpm.
fuga = 6hr

Nome: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

NASCIMENTO

Data de Nascimento: 22-9-1959

IMC: 30,84

Sexo: Feminino

Data do exame: 27-07-2023

Peso: 77 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DR. LUIZ SERGIO DE SOUZA

JUNIOR

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-07-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 533,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 44,0 e 176,5 minutos. O tempo total de sono foi de 336,5 min, eficiência de 63,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 61,8%; estágio N3: 15,3%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 7,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,7/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 123 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 74%, permanecendo 3,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 72 - 102 bpm e NREM de 71 - 104 bpm.

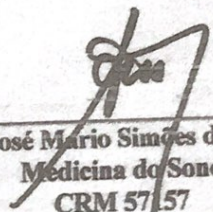
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 25,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=74%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (5,7/hora)
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157